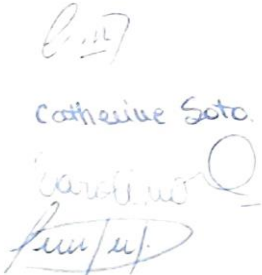


	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 11

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando

Leyton A. Peralillo

Elaborado por: EU Joselyn Castro. EU Carolina Cornejo. EU Sandy Guajardo EU Catherine Soto	Revisado por: EU María José Solís	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Enfermeras CESFAM Peralillo.	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad.	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 22 de Febrero 2024	Fecha: 27 de Febrero 2024.	Fecha: 12 de Marzo 2024
Firma: 	Firma: 	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 2 de 11

I. OBJETIVOS.

a.- Objetivo General.

Estandarizar el procedimiento de administración de medicamentos endovenosos para asegurar la correcta ejecución y disminuir el riesgo potencial de eventos adversos asociados.

b.- Objetivos específicos.

- Unificar criterios en el equipo de salud para la instalación y manejo de los pacientes que requieren administración de medicamentos endovenosos.
- Reducir el potencial riesgo de incidentes relacionados con la administración de medicamentos endovenosos, en nuestros usuarios.

II. ALCANCE

Dirigido a Enfermeras(os) y Técnicos de Enfermería que administran medicamentos endovenosos en los servicios clínicos o unidades del CESFAM Peralillo y sus Postas de Salud Rural.

III. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Médico/Cirujano Dentista: Responsable de la prescripción del medicamento o solución a administrar, la que debe ser escrita con letra clara y legible estipulando nombre del medicamento, dosis a administrar y vía de administración.

Enfermeras(os): Responsable de supervisar y realizar la administración y posterior registro del medicamento administrado, según indicación médica.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 11

Técnicos de Enfermería: Responsable de realizar la administración de medicamentos delegados por enfermera o médico de turno y posteriormente realizar el registro correspondiente de la acción realizada.

IV. DEFINICIONES

Infusión endovenosa intermitente: Administración de medicamentos por vía endovenosa, habitualmente se encuentra disuelto en un volumen pequeño de suero, con una duración dependiendo de las características del medicamento y las condiciones del paciente.

Infusión endovenosa continua: El medicamento se administra diluido en un suero, según indicación médica, en un tiempo superior a 4 horas; generalmente se utilizan bombas de infusión o fleboclisis, con cálculo de gotas por minuto.

Bolo o administración de terapia intravenosa directa: Administración por vía endovenosa de una dosis relativamente alta de medicamento en un periodo corto de tiempo. Puede administrarse solo o diluido.

EV: Endovenoso (a).

V. DESARROLLO

La administración de medicamentos endovenosos consiste en introducir un fármaco o solución directamente al torrente sanguíneo a través de un acceso venoso. Es una actividad cuya correcta ejecución es de gran relevancia para la salud de los usuarios y que debe considerar todas las medidas existentes para prevenir riesgos que se puedan asociar.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 11

La administración de medicamentos endovenosos se realiza según “los 6 correctos y los 4 yo”.

✓ **Los 6 Correctos**

Es la comprobación de aspectos importantes durante la preparación y administración de fármacos.

1. Paciente correcto
2. Medicamento correcto
3. Dosis correcta
4. Vía correcta
5. Horario correcto
6. Registro correcto

✓ **Los 4 Yo**

Promueve la responsabilidad en la preparación de los fármacos, de manera tal, que sea siempre la misma persona quien prepara, administra y registra, asumiendo la responsabilidad de la acción ejecutada

1. Yo preparo
2. Yo administro
3. Yo registro
4. Yo soy el responsable.

Los 6 “correctos” y 4 “yo” constituyen los 10 correctos en la administración de medicamentos EV en nuestro establecimiento.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 5 de 11

PASOS A SEGUIR EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS

A la hora de administrar una medicación se debe de actuar sistemáticamente, cumpliendo una serie de pasos:

A.- Preparar el material necesario.

B.- Preparar el medicamento.

C.- Elegir el lugar de inyección.

D.- Administrar el medicamento.

A. Preparar el material necesario

1. Riñón o bandeja, estéril o limpia y desinfectada con alcohol al 70%.
2. Insumos para administración de medicamentos (Bránulas, Jeringas, Mariposas).
3. Tómulas secas.
4. Alcohol al 70% o alcohol PAD.
5. Ligadura.
6. Tela adhesiva.
7. Fármacos.

B. Preparación del medicamento a administrar intravenosamente

1. Lavado clínico de manos.
2. Revisar fecha de caducidad en etiqueta de envase del medicamento a administrar.
3. Retirar la tapa protectora del frasco ampolla, desinfectar con alcohol al 70% el tapón del caucho, reconstituir según indicación del fabricante.
4. Limpiar con alcohol al 70% el extremo superior de la ampolla.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 11

5. Cargar la jeringa con la dosis necesaria según indicación.
6. Introducir el medicamento en el suero o fraccionador si se trata de infusión continua o intermitente.
7. Conservar la asepsia de las zonas estériles (en este caso el tapón de caucho y la aguja de la jeringa).

B1. Para infusión continua o intermitente:

1. Lavado de manos.
2. Reunir el material.
3. Verificar los 6 correctos.
4. Realizar lavado clínico de manos.
5. Lavar matraz de suero con agua y jabón, dejar secar (si corresponde)
6. Desinfectar gollete con alcohol al 70%.
7. Girar gollete para abrir matraz.
8. Retire excedente del matraz (si corresponde).
9. Sacar equipo de infusión (macro goteo, micro gotero según corresponda).
10. Cerrar la llave tipo roller del sistema de perfusión.
11. Retirar la tapa protectora del punzón y NO tocar el punzón en ningún momento.
12. Conectar el sistema de perfusión al matraz firmemente.
13. Invertir el matraz y colocarlo en el soporte de suero.
14. Presionar la cámara de goteo con los dedos para que se llene hasta $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ de su capacidad. Si no hacemos esa presión y dejamos que se rellene por gravedad, lo que entrará en el sistema será la solución a perfundir con aire.
15. Abrir la llave tipo roller más o menos hasta la mitad para cebar equipo de perfusión (la capacidad volumétrica de este es de 10 cc). Una vez que esté lleno de líquido, cerrar la llave.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 11

En la preparación de medicación por goteo intravenoso, además de preparar la sustancia a administrar, hay que calcular la velocidad de perfusión. Para ello se debe de tener en cuenta que:

1 ml = 20 gotas = 60 microgotas

1 gota = 3 microgotas

Fórmula Gotas (macrogotas)

$$\text{gotas/ min: } \frac{V}{T \times 3}$$

V = volumen a ser infundido en ml

T = tiempo en horas

3 = Constante

Fórmula Microgotas

$$\text{microgotas/min: } \frac{V}{T}$$

V = volumen a ser infundido en ml

T = tiempo en horas

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 8 de 11

Ejemplo: 1 litro de suero fisiológico en 6 horas

$V = 1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$
 $T = 6 \text{ horas}$
gotas/min. = ?

$$\text{gotas/min} = \frac{1000}{6 \times 3} = \frac{1000}{18} = 55.5$$

Respuesta: 56 gotas por minuto.

$V = 1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$
 $T = 6 \text{ horas}$
microgotas/min. = ?

$$\text{microgotas/min} = \frac{1000}{6} = 166.7$$

Respuesta: 167 microgotas por minuto.

B2. Para infusión endovenosa (EV) directa:

La administración EV directa de medicamentos se puede realizar directamente a la vena o a través del punto de inyección del equipo de perfusión por un catéter intravenoso obturado.

Se debe asegurar el correcto lavado del sistema después de cada dosis, para asegurar la administración completa del fármaco, teniendo precaución en pacientes con restricción de volumen.

En la administración EV directa, o bolo el vehículo junto con el medicamento, se sitúa en una jeringa y se infunde en un corto período de tiempo (3-5 minutos). Este tiempo puede variar según la naturaleza de los fármacos, y cada fabricante suele dar unas recomendaciones de tiempo de perfusión.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 9 de 11

C. Elegir el lugar de inyección

De acuerdo a acceso venoso del paciente.

D. Administración del medicamento

1. Informar al usuario el procedimiento a efectuar (si el estado del paciente lo permite).
2. Verificar 6 correctos (paciente, medicamento, dosis, vía, horario y registro).
3. Lavado clínico de manos.
4. Medicamentos en presentación vial: Retirar tapa protectora del frasco ampolla, desinfectar con alcohol al 70% el tapón de caucho, reconstituir si es necesario (liofilizados).
5. Medicamentos en presentación ampolla: Desinfectar con alcohol al 70% el extremo superior de la ampolla.
6. Cargar la jeringa con dilución y dosis de medicamento según indicación médica.
7. Trasladar los medicamentos a administrar en un riñón o bandeja estéril o limpia y desinfectada con alcohol al 70% a la unidad del paciente.
8. Desinfecte el puerto de administración (tapón y/o conexión dispuesta para estos fines). Utilice tórula de algodón con alcohol al 70% o alcohol PAD.
9. Evaluar la permeabilidad de la VVP, observar signos de flebitis y extravasación. Si es necesario reinstalar VVP.
10. Comience la administración del medicamento de forma lenta según instructivo del fármaco, observando siempre el estado del paciente para evaluar cambios y/o reacciones adversas.
11. Posterior a la administración de medicamento a través de fraccionador, realice lavado del sistema.
12. Dejar cómodo al paciente.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 10 de 11

13. Deseche el material.

14. Lávese las manos.

15. Registre en Dato de urgencia sistema Fonendo o ficha clínica Rayen según corresponda.

Consideraciones

- Durante la administración de todo medicamento, tener en consideración los parámetros vitales del paciente. Ante cualquier deterioro de la condición del paciente DETENGA la administración e informe de inmediato al médico.
- Revisar matraces de líquidos parenterales y ampollas en búsqueda de alteraciones, turbidez, partículas visibles, comprobar vigencia. Si hay alteraciones, eliminar o devolver a farmacia.
- Mantener tómulas secas en recipientes con tapa. Humedecer con alcohol al 70% solo en el momento de aplicarla.

VI. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Peralillo
- Unidad de Calidad y Seguridad del usuario CESFAM Peralillo
- Servicio de Urgencia Rural.
- Postas de Salud Rural.
- Equipo profesionales médicos y cirujanos dentistas.

VII. BIBLIOGRAFÍA.

- Protocolo de administración de medicamentos endovenosos Hospital Pichilemu.
- Protocolo de administración de medicamentos endovenosos Hospital Clínico San Francisco-Pucón.

	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ENDOVENOSA	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 11 de 11

IX. AUTORES.

- EU Catherine Soto.
- EU María José Solís.
- EU María Carolina Cornejo.
- EU Sandy Guajardo.
- EU Joselyn Castro.

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	TIPO	APROBACIÓN